



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) > [流感抗病毒藥劑](#)



流感抗病毒藥劑



全部收合

擴大使用對象中「其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員」應如何認定？

常見人口密集機構為一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、長照服務機構、榮譽國民之家、身心障礙福利機構、精神復健機構、兒童及少年安置及教養機構、矯正機關、軍營等機構等。

您如為前述人口密集機構之住民、工作人員，可於看診時主動向醫師表明，由醫師研判給藥。

最後更新日期 2026/7/23

擴大使用對象中「與流感重症高風險族群同住或其照顧者」，應如何認定？

流感重症高風險族群包括，未滿 5 歲幼兒、65 歲或以上長者、具有重大傷病、免疫不全(含使用免疫抑制劑者)或流感高風險慢性疾病的者、長期服用阿斯匹靈之未滿18歲兒童青少年、感染流感病毒後可能併發雷氏症候群（Reye syndrome）者、孕婦及產後兩週內之婦女、肥胖者、護理之家和其他慢性照護機構住民等。

若您與上述對象為同住家人，或您為上述人員之照顧者，可於看診時主動向醫師表明，由醫師研判給藥。

最後更新日期 2026/7/23

未滿18歲兒童及青少年如何計算及判定其BMI超過同齡第95百分位？ ^

因為兒童及青少年尚在生長發育，故肥胖定義與成人不同，參考國民健康署公布之「兒童及青少年生長身體質量指數(BMI) 建議值」，超過 95 百分位時為肥胖。未滿 18 歲兒童及青少年之年紀需計算至年/月/日，以「給藥日期」減「出生日期」，並以 0.5年為級距，所計算之 BMI 數值超過同齡第 95 百分位，即為公費流感抗病毒藥劑使用對象。

如男性病患出生日期為 100 年 1 月 1 日，給藥日期為 114 年 8 月 1 日，其足歲約為 14.6 歲，對應 14.5 歲之 BMI 第 95 百分位為 25.2，若該病患之 BMI 超過 25.2 即可依醫師研判給藥。

最後更新日期 2026/7/23

「產後兩週內之婦女」經評估需及時用藥者，其身分如何認定？ ^

產後兩週內之婦女，請提供孕婦手冊或新生兒出生日期證明相關文件，即可依醫師研判給藥。

最後更新日期 2026/7/23

未滿 5 歲及 65 歲以上之類流感患者，年齡計算操作型定義「『給藥年』減『出生年』 <6或≥65歲者」之計算方式為何？ ^

年齡計算操作型定義，係為避免第一線醫事人員因計算患者之年齡至年/月/日，致計算錯誤需賠償等困擾，故以「給藥年」與「出生年」的差值計算，並採稍寬鬆的定義，說明與範例如下：

(1)未滿5歲幼兒計算方式為「給藥年」-「出生年」<6，確保所有未滿5歲幼兒皆可納入，且稍微放寬部份已滿5歲幼兒亦可使用公費藥劑；以115年為給藥年為例，出生年介於110-115年次之幼兒類流感患者，皆可依醫師研判給藥。

(2)65歲以上長者之計算方式為「給藥年」-「出生年」 ≥ 65 ，確保所有年滿65歲以上長者皆可納入，且稍微放寬部份未達65足歲的成人亦可使用公費藥劑；以115年為給藥年為例，出生於50年次或以前之類流感患者，皆可依醫師研判給藥。

最後更新日期 2026/7/23

流感疫苗跟流感抗病毒藥劑有什麼不同？



流感疫苗可預防感染流感，有不活化疫苗、活性減毒疫苗等種類，藉由刺激人體產生抗體對抗病毒，使人體免於感染流感或降低感染發病後的嚴重程度，保護力約可維持半年至1年；而流感抗病毒藥劑是用來治療或預防流感病毒感染，服用後可以減輕症狀、縮短病程、減少併發症；發病前服用則可預防感染，一旦停止服藥後即不產生預防效果，因此兩者的原理與作用皆有不同。

最後更新日期 2023/10/3

接種過流感疫苗還可以服用流感抗病毒藥劑嗎？



- 1.絕大部分流感疫苗是不活化疫苗，與流感抗病毒藥劑之作用機轉不同，不會互相影響。
- 2.但因鼻噴式流感疫苗為活性減毒疫苗，若於接種後兩週內因感染流感而使用流感抗病毒藥物，可能影響疫苗保護力。因此，倘發生前述情形，應重新接種不活化流感疫苗。

最後更新日期 2025/12/3

什麼是流感抗病毒藥劑？公費藥劑有哪些？



流感抗病毒藥劑是可以預防或治療流感的藥品。目前政府採購儲備之公費流感抗病毒藥劑，包括口服式oseltamivir (如克流感膠囊Tamiflu®及易剋冒膠囊Eraflu®)及吸入式zanamivir (瑞樂沙旋達碟Relenza®)，均為神經胺酸酶抑制劑，可有效抑制流感病毒複

製，並可同時治療A及B型流感。另有點滴靜脈注射液劑型瑞貝塔[®] (Rapiacta[®])，可提供新型A型流感通報個案使用。

最後更新日期 2025/7/11

公費供應之oseltamivir與zanamivir的差異在哪？



	oseltamivir（克流感膠囊 Tamiflu [®] 、易剋冒膠囊 Eraflu [®] ）	zanamivir（瑞樂沙旋達碟 Relenza [®] ）
藥物 種類	神經胺酸酶抑制劑	神經胺酸酶抑制劑
給藥 方式	口服	經口吸入
適用 年齡	成人和兒童(包含足月新生兒)； 未滿13歲且體重40公斤以下者 需依體重調整劑量。	5歲（含）以上之青少年與成人。
副作用	1. 最常通報的藥物不良反應為，噁心、嘔吐及頭痛，會在1-2天內自然消退。 2. 其他曾報告過的不良反應包括：過敏性皮膚反應(如皮膚疹、濕疹、蕁麻疹、多型性紅斑、面部水腫、史帝芬強生症候群及毒性上皮組織壞死等)、肝炎、肝酵素上升。 3. 日本曾出現神經精神方面案例（行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等），多發生於未成年患者。	1. 曾報告的事件包括，過敏反應(如口咽部水腫、顏面水腫)、血管迷走神經反應(如發燒及脫水)、支氣管痙攣、呼吸困難、皮疹、蕁麻疹、嚴重皮膚反應(包括多型性紅斑、史帝芬強生症候群及毒性表皮壞死溶解症)等，皆極為罕見。 2. 接受包括瑞樂沙在內的神經胺酸酶抑制劑治療時，有癲癇、譫妄、幻覺與異常行為等表現，主要發生於疾病初期，往往突然出現後又迅速消退。

最後更新日期 2026/9/1

醫師遇到流感病患該如何處理？



醫師遇到流感病患，應提高警覺，如符合流感併發重症及新型A型流感通報病例定義應儘速通報，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件之民眾，不需快篩，即可及早給予公費流感抗病毒藥劑，以減少嚴重併發症及死亡的發生。

最後更新日期 2026/7/23

抗病毒藥劑什麼時候投藥最好？療程多久？



在流感症狀開始後48小時內使用效果最好，即使症狀出現時間已經超過48小時後使用仍然有效，所以當出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、頭痛等症狀時，應儘速就醫，並依醫師指示使用藥物。

最後更新日期 2025/9/10

出現類流感症狀就需要服用流感抗病毒藥劑嗎？



由於引起類流感症狀之病原體很多，流感抗病毒藥劑僅能治療流感病毒引起之感染症狀，因此須經由醫師診療後，再依指示用藥。

最後更新日期 2023/10/3

我需不需要於流感流行季時，自行準備流感抗病毒藥劑？



不建議。流感抗病毒藥劑為處方用藥，需經醫師評估後使用，若毫無節制使用流感抗病毒藥劑，有可能產生抗藥性的病毒株。

最後更新日期 2026/7/23

懷孕期間服用流感抗病毒藥劑安全嗎？



對於孕婦而言，感染流感可能會引發嚴重的併發症，甚至死亡。目前沒有任何研究顯示，孕婦使用流感抗病毒藥劑會增加自己或胎兒不良預後的風險，在懷孕動物的研究中，也未顯示流感抗病毒藥劑具致畸胎性。同時孕婦使用流感抗病毒藥劑，可降低入住加護病房與死亡之風險。因此，對於罹患流感之孕婦，使用流感抗病毒藥劑的好處大於可能的風險，建議孕婦如有流感症狀應儘速就醫，並依醫師評估及建議使用流感抗病毒藥劑。

最後更新日期 2023/10/3

公費流感抗病毒藥劑的使用條件有哪些？



詳見「[公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表](#)」

最後更新日期 2026/8/14

公費流感抗病毒藥劑的儲備目的及使用對象是如何訂定？



詳見「[儲備目的及使用原則](#)」

最後更新日期 2026/7/23

流感抗病毒藥劑健保有給付嗎？



目前流感抗病毒藥劑並未納入健保給付，屬應自費之藥品。

最後更新日期 2026/7/23